

Leczenie wstydu *u źródła*

CFT celuje wprost w wstyd i samokrytykę — dwa centralne objawy DSO. Trening systemu uspokajania, niedostatecznie rozwiniętego w wyniku braku wczesnego ciepła.

CZAS: 12–24 sesji + codzienna praktyka **REALIZACJA:** Faza 2 lub równolegle z Fazą 1

ŹRÓDŁO: Gilbert (2010, 2014, *Compassion-Focused Therapy*); Kirby i in. (2017, metaanaliza 21 RCT); Beaumont i in. (2012, RCT C-PTSD); Longe i in. (2010, fMRI samokrytyki); Kim i in. (2020, fMRI samowspółczucia)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy systemy regulacji emocji**: zagrożenie, napęd, uspokojenie. W C-PTSD układ uspokojenia jest niedorozwinięty, układ zagrożenia chronicznie aktywowany. W sekcji 02 — **cztery praktyki CFT**: *Compassionate Mind Training*, wyobrażenia współczujące, oddech kojący, list współczujący. Sekcja 03 — **twoja diagnoza systemów** + plan praktyki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

CFT (*Compassion-Focused Therapy*, Gilbert, 2009, 2010, 2014) jest terapią **specyficznym zaprojektowaną** do pracy z wstydem i samokrytyką — dwoma **centralnymi** cechami C-PTSD (klaster DSO „negatywna koncepcja siebie”). Teoria: **trzy systemy regulacji emocji**: (1) **zagrożenie** (ang. *threat*) — ciało migdałowe, kortyzol, lęk/gniew/wstyd („uciekaj, walcz, zamróż”); (2) **napęd** (*drive*) — dopamina, pragnienie, osiągnięcia („zdobywaj, osiągaj”); (3) **uspokojenie** (*soothing*) — oksytocyna, endorfiny, poczucie bezpieczeństwa i ciepła („jestem bezpieczny/-a, wystarczający/-a”). **W C-PTSD**: system zagrożenia jest **chronicznie hiperaktywowany**, system uspokojenia jest **niedorozwinięty** — bo wczesne środowisko **nie dostarczyło** doświadczeń ciepła, pocieszenia, akceptacji. Samokrytycyzm (wewnętrzny krytyk) **aktywuje** system zagrożenia — ciało reaguje na samokrytykę **jak na atak z zewnątrz**. Longe i in. (2010, fMRI): samokrytyka aktywuje ciało migdałowe i przednią wyspę. Kim i in. (2020, fMRI): samowspółczucie aktywuje brzuszne prążkowie i brzuszno-przyśrodkową korę przedczołową — **odwrotny wzorzec**. **CFT celowo buduje system uspokojenia** przez: (a) *Compassionate Mind Training* — budowanie „współczującego siebie” jako wewnętrznego głosu: ciepły, mądry, odważny, nieoceniający; (b) **wyobrażenia współczujące** — wizualizacja postaci współczującej (ang. *compassionate other*); (c) **oddech kojący** (*soothing rhythm breathing*) — wolny, rytmiczny, aktywujący n. X; (d) **list współczujący** — pisanie do siebie z perspektywy współczującej osoby. Kirby i in. (2017, metaanaliza 21 RCT): CFT istotnie **redukuje** samokrytycyzm ($d = 0,49$), wstyd ($d = 0,45$) i depresję ($d = 0,64$). Beaumont i in. (2012, RCT): CFT dodane do leczenia standardowego u pacjentów z C-PTSD — istotna redukcja wstydu i retrospekcji. **Dlaczego CBT nie wystarcza**: klient z toksycznym wstydem („jestem do niczego”). Restrukturyzacja poznawcza pyta o dowody, ale **wstyd nie reaguje na dowody** — wstyd jest somatyczny, nie poznawczy. Uważność pomaga obserwować, ale **nie zmienia**. Bez treningu aktywnego współczucia klient pozostaje w systemie zagrożenia — brak alternatywy.

01 Trzy systemy regulacji emocji (Gilbert)

1 · ZAGROŻENIE

Ciało migdałowe, kortyzol.

Lęk, gniew, wstyd. „Uciekaj, walcz, zamróż.” W C-PTSD: **chronicznie hiperaktywowany**.

2 · NAPĘD

Dopamina, pragnienie.

Osiągnięcia, ekscytacja, pogoń za nagrodą. „Zdobywaj, osiągaj.” W C-PTSD często jako **ucieczka od wstydu** (perfekcjonizm, *pracholizm*).

3 · USPOKOJENIE

Oksytocyna, endorfiny.

Bezpieczeństwo, ciepło, akceptacja. „Jestem bezpieczny/-a, wystarczający/-a.” W C-PTSD: **niedorozwinięty** — **cel CFT to go budować**.

02 Cztery praktyki CFT — trening systemu uspokojenia

A • COMPASSIONATE MIND TRAINING

Budowanie „współczującego siebie”. Wewnętrzny głos: *ciepły, mądry, odważny, nieoceniający*. Codzienna 5–10 min praktyka wyobrażania siebie z tymi cechami.

B • WYOBRAŻENIE WSPÓŁCZUJĄCE

Wizualizacja postaci współczującej. Realna lub wymyślona — opiekun, mentor, postać z książki, własne „ja” za 10 lat. Wyobrażaj sobie jej obecność, ciepły wyraz twarzy, głos.

C • ODDECH KOJĄCY

Wolny, rytmiczny. 5 sek wdech, 5 sek wydech, przez 5–10 min. Aktywuje n. X (gałąź brzuszną). Tonizuje system uspokojenia. Wykonywać *poza* kryzysem dla treningu.

D • LIST WSPÓŁCZUJĄCY

Pisanie do siebie z perspektywy współczującej osoby. List zaczynający się: *„Drogi/-a..., widzę, jak ciężko ci jest...”*. 15–20 min. Czytanie sobie głośno powtórnie.

03 Moja diagnoza systemów + plan praktyki

MÓJ DOMINUJĄCY SYSTEM

— zagrożenie (lęk, czujność) / napęd (perfekcjonizm, pogoń) / uspokojenie; zwykle mieszany; po czym poznaję

KIEDY OSTATNIO DOŚWIADCZYŁEM/-AM STANU USPOKOJENIA

— bezpieczeństwa, ciepła, spokoju; nawet krótko; co go wywołało

MOJA POSTAĆ WSPÓŁCZUJĄCA

— kogo wyobrażam, jak wygląda, brzmi; może być realna lub wymyślona

PLAN PRAKTYKI NA 8 TYGODNI

— jedna z czterech praktyk codziennie, 10 min; CFT wymaga regularności, nie intensywności

Klucz: CFT *nie* jest „pozytywnym myśleniem” ani „rozpieszczaniem siebie” — jest **biologicznym treningiem** układu uspokojenia. Kirby i in. (2017, metaanaliza 21 RCT): istotna redukcja samokrytyki, wstydu, depresji. Gilbert (2010): *„współczucie nie jest miękkie — wymaga odwagi, by spojrzeć w cierpienie i pozostać”*. CFT bezpośrednio adresuje to, czego restrukturyzacja CBT i uważność nie sięgają: wstyd *nie reaguje na dowody*, bo jest somatyczny, nie poznawczy. Trening współczującego „ja” buduje *alternatywę* dla systemu zagrożenia — bez tej alternatywy klient pozostaje w cyklu wstydu i samokrytyki, nawet po latach terapii. *Pierwszy miesiąc praktyki często wywołuje opór („nie zasługuję, jestem dramatyczny/-a, to dla słabych”)* — to głos zinternalizowanego inwalidatora. Z czasem opór słabnie.

△ U niektórych pacjentów praktyki współczujące aktywują wstyd lub żalobę (*„nikt nigdy mi tego nie dał — dlaczego sam/-a sobie mam dawać?”*). To nie znak, że CFT nie działa — to znak, że dotyczy deprivacji emocjonalnej. Warto pracować z terapeutą znającym CFT, nie samemu, jeśli te reakcje są silne. Gilbert (2010) opisuje „fear of compassion” jako częste zjawisko — opracowany jest osobny moduł pracy z tym lękiem.